



Organisation d'un Réseau de Centres Hospitaliers Impliqués Dans la surveillance
Épidémiologique et la réponse aux Emergences

Journée de travail co-leaders GT RATB/SIB – 17/10/2025

Mélanie COLOMB-COTINAT (HCL Lyon)

Delphine VIRIOT, Ghaya BEN HMIDENE, Marion OPATOWSKI, Valentin COURTILLET (SpF)

Julien GROSJEAN, Stéfan DARMONI, Mélanie DALIGAULT, Francesco MONTI, Hugues HEDIN, Solenn CATHERINE (CHU Rouen)

PROGRAMME

- 10h – 12h : présentation de l'entrepôt de données de santé du CHU de Rouen, et exemples d'utilisation
- 12h – 13h : déjeuner
- 13h – 16h : échange sur les problématiques antibiorésistance, consommation d'antibiotiques et infections bactériennes sévères. La priorité sera mise sur la thématique bactérienne.

Travaux GT RATB/GT SIB

- Présentation EDSaN (Julien)
- Exemples de requêtes pour visualiser la présentation des résultats dans l'EDS
- Discussions :
 - Statuer avec les bactériologistes/infectiologues de la pertinence de conserver date de plvt, date de résultat (technique), date de rendu de résultat (validation biologique) dans l'EDS

Travaux GT RATB/GT SIB

- Questions/Remarques issues de l'atelier structuration des données de bactério :
- Il est rappelé que le rendu BLSE dépend des pratiques locales et ne sera donc pas disponible partout. Sandra Fournier suggère d'utiliser la résistance aux C3G qui est disponible partout et retenu au niveau Européen. Dans l'objectif de **caractériser cette résistance, si la notion de la présence ou non de BLSE n'est pas disponible dans le SGL, une alternative est de regarder la résistance au cefotaxime** (=résistance aux céphalosporines de 3ème génération ou C3G). C'est un indicateur plus large que la présence de BLSE, c'est-à-dire que toutes les EBLSE sont résistantes aux C3G mais toutes les entérobactéries résistantes aux C3G ne sécrètent pas de BLSE. C'est l'indicateur utilisé dans le réseau de surveillance européen EARS, <https://atlas.ecdc.europa.eu/public/> .
- L'approche la plus pragmatique est de travailler par couple germe/résistance à 1 ATB plutôt que de vouloir être exhaustif.
- Les + pertinents cliniquement doivent être produits en priorités. Faire valider par SpF et CNR en GT.

Travaux GT RATB/GT SIB

- GT RATB Présentation EB SpF v2 (Marion, Ghaya)
- Discussions :
 - Marion a transformé les définitions des indicateurs de la stratégie nationale en calculs.
 - Pour la v1, il est décidé de reproduire la méthodologie SPARES à l'identique. Pour les calculs de consommation d'ATB, nous restons sur la dispensation. (A Rouen, une expérimentation locale vise à comparer le delta avec un calcul basé sur l'administration).
 - Pour la v2, nous irons plus loin en exploitant les besoins identifiés et faisables remontés dans l'EB. Plusieurs pistes dont la modification du dénominateur (en Nbre d'admissions), les analyses rétrospectives pour avoir des tendances sur 5 ans) et l'ajout de nouveaux indicateurs...
 - Besoin, + value d'ORCHIDEE par rapport aux surveillances nationales actuelles = données + réactives pour répondre aux demandes du ministère (virus, bactéries, mycoplasmes dans les cas d'émergence)
 - Points d'attention : Pour les résistances, la méthode de dédoublonnage est différente selon qu'on calcule un indicateur de densité ou de proportion. SpF prépare un tableur avec les indicateurs + leurs spécificités.
 - Par ailleurs, il est mentionné le fait que SPARES dispose d'outils de contrôle qualité déjà éprouvés (script). Il sera intéressant de les associer dans les GT relatifs à l'évaluation et de pouvoir utiliser ces outils.
 - Pour évaluer le bassin d'attractivité d'un ES, utilisation possible de l'outil Odyssée. L'échelle de l'hôpital est généralement régionale.
 - Pour la mise en place des flux, il y a aura un calcul pour le numérateur + 1 script commun à plusieurs GT pour le calcul du dénominateur (JH)
 - Utilisation de l'ATIH au lieu des listes d'UF pour la standardisation méthodo

Travaux GT RATB/GT SIB

- Discussions questions Mélanie sur l'EB GT RATB :

1/Objectifs à court terme:

la liste des Enterobactéries choisie est elle restrictive ou s'agit il d'un exemple ? Car j'ajouterai bien *Citrobacter freundii/braakii*, à Lyon c'est notre champion local.

Nous soumettrons une liste au GT plus détaillée, on peut séparer les citrobacter des « autres entérobactéries »)

pourquoi avoir intégré *Enterococcus faecalis* ?

L'idée était d'avoir les entérocoques. *E. faecalis* est tout de même assez fréquent, même si la résistance est assez basse. On peut en discuter. Par contre je me rends compte que parce qu'on était focalisé sur la méthodologie Spares, nous n'avons pas mis *S. pneumoniae* par exemple, qui est tout de même important. Globalement, les membres du GT n'ont pas beaucoup réagit aux choix des espèces bactériennes.

2/Objectifs à moyen terme :

la possibilité de tester des nouveaux indicateurs de suivi de la consommation d'antibiotiques comme le nombre de jours de traitement par exemple a t'elle été évoquée ?

Oui, c'est inclus dans « indicateurs liés aux recommandations et aux bonnes pratiques. Sachant que l'on sait que les indicateurs liés aux recommandations seront difficiles à construire, et plus ou moins pertinents (les ES suivant parfois les recommandations locales et non pas nationales). Il sera donc peut-être simplifié, ce qui inclue le nombre de jours de traitement

L'indicateur One Health de multisensibilité me semble peu adapté à des données hospitalières, mais sait-on jamais, il faut tester.

Oui on est d'accord, j'en avais discuté avec Lucie (Collineau), mais nous avons convenu que dans un contexte de surveillance intégrée, il pourrait être intéressant tout de même de voir ce qu'il en est.

Travaux GT RATB/GT SIB

- Discussions GT SIB :

- Pour EPIBAC, la surveillance actuelle est biologique (microbio). L'intérêt d'ORCHIDEE sera l'implication des cliniciens + l'utilisation du Traitement Automatique de la Langue
- EPIBAC rend de l'incidence. Nécessité de disposer de données réactives (à la semaine/mois) déclinées :
 - CIM-10
 - CIM-10 ou confirmation bio
 - Biologique
- EPIBAC effectue un double redressement pour les 20% du territoire non-couvert (à la fois pour les ES qui ne participent pas et pour les données manquantes de ceux qui participent)
- Dans la v0, reproduction d'EPIBAC, v1, ajout de la gravité associée au services ou aux actes. En associant la CIM-10 + sévérité, nous devrions frôler l'exhaustivité en terme de détection des cas.
- Intérêt de récupérer les comorbidités, le statut vaccinal ou la prise d'un traitement.
- Importance de solliciter un groupe de spécialistes pour définir les signes cliniques associés à chaque bactérie.